

1. RECOMMANDATIONS

Les recommandations suivantes sont formulées sur la base des constats de l'évaluation mi-parcours et visent à éclairer les décisions dans le projet TUMA+, notamment en résolvant les défis, les limites ou les échecs énumérés dans le rapport, ainsi qu'à éclairer la conception et les programmes futurs.

1. Recommandations stratégiques (pour le consortium)

A. Adapter les stratégies selon les contextes sécuritaires

Il est recommandé d'adapter les stratégies selon les contextes sécuritaires. L'objectif est de développer des plans différenciés pour les zones stables et instables. D'ici quatre mois, toutes les zones instables doivent avoir un plan d'action adapté.

Pour cela, il faut cartographier les zones selon leur stabilité et leur contrôle par les autorités. Dans les zones instables, il est essentiel de privilégier la sensibilisation communautaire, la disponibilité des intrants, le renforcement des infrastructures sanitaires et des mécanismes de plaidoyer alternatifs. Dans les zones stables, on doit intensifier le plaidoyer institutionnel et les mécanismes de redevabilité.

Un système d'alerte précoce doit également être mis en place pour ajuster rapidement les stratégies en cas de changement de contexte. Cette adaptation est cruciale car l'impact du plaidoyer est limité dans les zones où les autorités ne contrôlent plus.

B. Renforcer la pérennisation des acquis dès maintenant

L'objectif est d'intégrer des mécanismes de durabilité dans toutes les activités en cours. D'ici douze mois, 80% des activités clés doivent avoir un plan de transition documenté.

Pour cela, il faut identifier les activités avec le plus fort potentiel de pérennité, comme les sensibilisations communautaires et les services intégrés. Il est essentiel de renforcer les capacités des RECOs et YATs pour assurer leur autonomie. Les activités du projet TUMA+ doivent être progressivement intégrées dans les structures officielles, comme les centres de santé.

Il est également important de développer des stratégies de financement local pour les activités essentielles et de créer des réseaux d'appui mutuel entre zones pour partager ressources et expériences. Cette transition est cruciale pour garantir la durabilité, car les participants s'inquiètent de la continuité après le projet.

C. Renforcer le suivi et l'apprentissage adaptatif

Il est recommandé de renforcer le suivi et l'apprentissage adaptatif. L'objectif est de mettre en place un système de suivi continu pour permettre des ajustements rapides. D'ici trois mois, toutes les zones doivent disposer d'un mécanisme de feedback mensuel opérationnel.

Pour cela, il faut établir des mécanismes de feedback réguliers avec les participants au projet, RECOs, YATs et prestataires de santé. Des espaces de dialogue trimestriels doivent être créés pour identifier rapidement les défis et ajuster les stratégies. Il est également important de développer des indicateurs simples pour mesurer les changements comportementaux et normatifs.

Les leçons apprises doivent être systématiquement documentées et partagées entre les zones. Enfin, des ateliers d'apprentissage semestriels doivent être organisés pour capitaliser sur les expériences et ajuster les approches. Ce système d'apprentissage adaptatif est crucial pour

améliorer l'efficacité, car des besoins de suivi post-activités et des défis nécessitent des ajustements rapides.

2. Recommandations opérationnelles (pour les équipes terrain)

A. Renforcer les formations techniques sur la VBG et la PSHEA pour les RECOs

Il est recommandé de renforcer les formations techniques sur la VBG et la PSHEA pour les RECOs. L'objectif est d'organiser des formations approfondies pour que 100% des RECOs actifs aient acquis une maîtrise suffisante d'ici six mois, avec 80% démontrant une maîtrise satisfaisante lors des évaluations pratiques.

Pour cela, il faut organiser des sessions de formation spécifiques sur la VBG (identification, prise en charge, références) et la PSHEA (comportements attendus, signalement). Des sessions de renforcement post-formation avec des mises en situation pratiques doivent également être mises en place. Un système d'appui technique continu avec des référents doit être créé pour répondre aux questions des RECOs.

Il est important de développer des outils de référence simples adaptés à leur niveau d'instruction et d'organiser des visites de supervision ciblées pour corriger rapidement les lacunes. Cette formation est essentielle, car les RECOs expriment un besoin de connaissances plus approfondies sur la VBG et la PSHEA pour mener des sensibilisations efficaces.

B. Améliorer la qualité des services et l'accueil dans les structures sanitaires

Il est recommandé d'améliorer la qualité des services et l'accueil dans les structures sanitaires. L'objectif est de former tous les prestataires de santé sur un accueil respectueux et confidentiel pour les jeunes et les femmes. D'ici quatre mois, 100% des prestataires dans les 18 structures de santé doivent avoir reçu cette formation, avec une augmentation de 30% des scores de satisfaction de la communauté.

Pour cela, il faut organiser des formations spécifiques sur l'accueil sans jugement, en mettant l'accent sur la confidentialité et le respect. Des mécanismes de feedback, comme des boîtes à suggestions et des enquêtes de satisfaction, doivent être mis en place. Il est également essentiel de créer des systèmes de suivi pour garantir que les services restent gratuits pour les jeunes et d'organiser des visites de supervision pour observer les pratiques d'accueil.

Enfin, des protocoles d'accueil standardisés doivent être développés pour toutes les structures. Cette amélioration est cruciale, car les bénéficiaires soulignent un besoin d'amélioration de l'accueil et de la confidentialité, des éléments clés pour l'utilisation des services.

C. Renforcer les capacités des YATs en suivi budgétaire et redevabilité

Il est recommandé de renforcer les capacités des YATs en suivi budgétaire et redevabilité. L'objectif est de former tous les YATs actifs (54 membres dans 9 zones) sur le suivi budgétaire et les techniques de plaidoyer avancées d'ici quatre mois, avec 70% capables de suivre efficacement les budgets ETD. Pour cela, il faut organiser des formations intensives sur la lecture de budgets, l'identification des décaissements et le suivi d'achats. Des formations sur les techniques de plaidoyer, la mobilisation communautaire et la redevabilité sociale doivent également être incluses. Il est important de fournir des outils de suivi simplifiés adaptés au contexte et de mettre en place un accompagnement technique continu par l'équipe plaidoyer du projet TUMA+.

Enfin, des visites d'échange entre YATs de différentes zones doivent être organisées pour partager les expériences. Ce renforcement est crucial, car les YATs expriment des frustrations face aux objectifs non atteints et aux promesses non tenues, et une meilleure formation leur permettra de suivre efficacement les engagements.

D. Promouvoir l'accès gratuit aux services dans toutes les zones

Il est recommandé de promouvoir l'accès gratuit aux services dans toutes les zones. L'objectif est d'étendre la gratuité des services DSSR pour les jeunes dans toutes les 18 structures de santé ciblées d'ici six mois, avec une vérification trimestrielle.

Pour cela, il faut intensifier le plaidoyer auprès des autorités locales pour garantir la gratuité et sensibiliser les prestataires de santé à ne pas facturer ces services. Des systèmes de suivi doivent être mis en place pour vérifier que les services restent gratuits, incluant des enquêtes auprès de la communauté et des vérifications régulières.

Des campagnes de sensibilisation communautaire sur la gratuité des services DSSR doivent également être organisées ou renforcées, et des mécanismes de signalement pour les cas de facturation aux jeunes doivent être créés. Enfin, il est important de documenter et de partager les expériences réussies de zones où la gratuité est effective. Cette mesure est essentielle, car la gratuité est un facteur clé d'accès aux services de DSSR, comme l'indiquent les retours des bénéficiaires.

E. Renforcer le suivi post-activités et l'accompagnement des bénéficiaires

Il est recommandé de renforcer le suivi post-activités et l'accompagnement des bénéficiaires. L'objectif est de mettre en place un système de suivi pour accompagner les bénéficiaires et mesurer l'impact. D'ici six mois, 80% des activités clés doivent disposer d'un mécanisme de suivi opérationnel.

Pour cela, il faut développer des outils de suivi simplifiés pour les RECOs afin de documenter les résultats et témoignages des bénéficiaires. Des visites de suivi régulières (trimestrielles) doivent être organisées pour comprendre l'évolution des comportements. Il est également important de mettre en place des mécanismes de feedback communautaire pour identifier les besoins persistants.

Des espaces d'écoute et d'orientation doivent être créés pour les jeunes et les femmes ayant des questions spécifiques. Les changements de comportement observés doivent être systématiquement documentés et partagés pour améliorer les interventions. Enfin, des sessions de renforcement périodiques doivent être organisées pour maintenir l'engagement et l'appropriation.

Cette approche est essentielle, car l'évaluation montre un besoin critique de suivi post-activités pour éviter la régression et pérenniser les changements, un besoin également exprimé par les bénéficiaires.

F. Intégrer spécifiquement la gestion de l'hygiène menstruelle pour les collégiens

Il est recommandé d'intégrer spécifiquement la gestion de l'hygiène menstruelle pour les collégiens. L'objectif est de former 100% des RECOs sur ce sujet d'ici quatre mois et d'organiser des sensibilisations dans au moins 20 écoles d'ici huit mois.

Pour cela, il faut intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle dans les formations des RECOs et développer des modules adaptés aux collégiens. Des sensibilisations ciblées doivent être organisées en collaboration avec les directions scolaires et les enseignants. Il est également

important de mettre en place des espaces d'écoute et d'orientation dans les écoles pour les collégiens.

Les RECOs doivent être formés sur les techniques de communication adaptées aux adolescents, et des kits de dignité (serviettes hygiéniques, etc.) doivent être fournis dans les écoles lorsque cela est possible. Cette intégration est essentielle, car les jeunes filles expriment des besoins spécifiques en matière d'hygiène menstruelle, et cela permettrait d'atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires.

3. Recommandations institutionnelles (pour les autorités, bailleurs, etc.)

A. Responsabiliser les détenteurs de pouvoir pour des engagements financiers durables

Il est recommandé de responsabiliser les détenteurs de pouvoir pour garantir des engagements financiers durables en faveur de la DSSR. L'objectif est que 100% des ETD dans les zones ciblées signent des lettres d'engagement avec des budgets spécifiques pour la DSSR d'ici six mois, avec 80% respectant les calendriers de décaissement trimestriels.

Pour cela, il faut créer des comités de suivi budgétaire DSSR au niveau de chaque ETD, composés de représentants des autorités locales, YATs, prestataires de santé et leaders communautaires. Des réunions trimestrielles de redevabilité doivent être organisées, où les autorités présenteront publiquement les budgets alloués, les décaissements et les achats réalisés.

Les engagements doivent être formalisés par des lettres signées spécifiant les montants, calendriers et mécanismes d'achat. Il est également important d'intégrer une ligne budgétaire DSSR dans les budgets annuels des ETD et dans les Plans de Développement Locaux (PDL). Des tableaux de bord de suivi budgétaire doivent être affichés publiquement dans les mairies et centres de santé, et des séances de passation obligatoires entre autorités sortantes et entrantes doivent être organisées pour assurer la continuité des engagements.

Cette approche est essentielle, car l'évaluation révèle que les budgets ne sont pas toujours décaissés à temps et que des ruptures d'approvisionnement persistent, nécessitant des mécanismes de responsabilisation renforcés.

B. Renforcer la transparence budgétaire et la redevabilité sans conditionner l'accès

Il est recommandé de renforcer la transparence budgétaire et la redevabilité tout en garantissant l'accès gratuit et inconditionnel aux services DSSR. L'objectif est que 100% des ETD publient des rapports d'exécution budgétaire DSSR trimestriels accessibles au public d'ici six mois, avec des audiences publiques organisées trimestriellement.

Pour cela, il faut publier des rapports d'exécution budgétaire dans des formats simplifiés et accessibles (graphiques, illustrations, langues locales). Des audiences publiques trimestrielles doivent être organisées pour permettre aux communautés d'interpeller les autorités sur leurs engagements DSSR.

Il est également important de mettre en place des mécanismes de signalement citoyen (boîtes à suggestions, lignes téléphoniques dédiées) pour signaler les ruptures d'approvisionnement. Des espaces d'affichage transparents doivent être créés dans les mairies et centres de santé pour informer sur les budgets alloués, les achats effectués et les services rendus.

La sensibilisation des communautés sur leurs droits en matière de santé reproductive et sur les mécanismes de redevabilité est essentielle. Il convient de clarifier que l'accès aux services DSSR pour les jeunes est gratuit et inconditionnel, indépendamment du paiement de taxes.

Cette approche est cruciale, car l'évaluation révèle un besoin de transparence budgétaire tout en garantissant que l'accès reste gratuit, les bénéficiaires exprimant des préoccupations concernant la conditionnalité de l'accès.

C. Institutionnaliser les engagements DSSR dans les structures officielles

Il est recommandé d'institutionnaliser les engagements DSSR dans les structures officielles. L'objectif est d'intégrer ces engagements dans les documents officiels des ETD pour assurer leur continuité au-delà des changements de personnel. D'ici douze mois, 100% des ETD dans les zones ciblées doivent avoir intégré une ligne budgétaire DSSR dans leurs budgets annuels et règlements intérieurs.

Pour cela, il faut plaider pour l'insertion d'une ligne budgétaire DSSR dans les budgets annuels de tous les ETD et intégrer ces engagements dans les Plans de Développement Locaux (PDL). Les engagements DSSR doivent également être inclus dans les règlements intérieurs des ETD pour garantir leur pérennité.

Il est essentiel de créer un registre des engagements DSSR documenté par ETD, avec un historique. Des séances de passation obligatoires entre autorités sortantes et entrantes doivent être organisées pour assurer la transmission formelle des engagements. Enfin, il est crucial de former systématiquement les nouvelles autorités sur les engagements DSSR et leurs responsabilités légales.

Cette institutionnalisation est nécessaire, car l'évaluation révèle que la continuité des engagements dépend de la stabilité des autorités, et cela garantirait la pérennité des initiatives au-delà des changements de personnel.

D. Renforcer les capacités des autorités locales en gestion budgétaire DSSR

Il est recommandé de renforcer les capacités des autorités locales en gestion budgétaire DSSR. L'objectif est de former 100% des autorités locales (chefs d'ETD, responsables finances) dans les zones ciblées sur la planification budgétaire pour la santé, les mécanismes d'achat de contraceptifs et la gestion transparente des fonds publics d'ici huit mois.

Pour cela, il faut organiser des sessions de sensibilisation sur les responsabilités légales des autorités en matière de santé publique et DSSR. Des formations doivent être proposées sur la planification budgétaire pour la santé, l'allocation de ressources pour la DSSR, ainsi que sur les mécanismes d'achat de contraceptifs (procédures, fournisseurs, qualité, gestion des stocks).

Il est également essentiel de former sur la gestion des fonds publics et la transparence budgétaire. L'accès des autorités aux ressources techniques (CTMP, PNSA) doit être facilité pour un soutien technique accru. Enfin, des visites d'échange entre ETD doivent être organisées pour partager les expériences réussies.

Ce renforcement est crucial, car l'évaluation révèle que certaines autorités rencontrent des limitations financières et des difficultés dans la gestion des budgets DSSR, et une meilleure formation améliorerait leur efficacité.

E. Soutenir le renforcement socioéconomique des jeunes et des femmes pour l'autonomie décisionnelle

Il est recommandé de soutenir le renforcement économique des bénéficiaires pour favoriser leur autonomie décisionnelle. L'objectif est de développer des activités génératrices de revenus (AGR) individuelles et collectives afin que 60% des bénéficiaires ciblés (femmes et jeunes) aient accès à des AGR ou à des mécanismes d'épargne d'ici douze mois.

Pour cela, il faut renforcer les AVEC existantes et en créer de nouvelles dans les zones ciblées. Des AGR individuelles doivent être développées en plus des AGR collectives pour répondre aux besoins variés des bénéficiaires. Il est important de diversifier les activités génératrices de revenus en fonction des contextes locaux et des opportunités.

Le renforcement des capacités d'épargne et de gestion financière des bénéficiaires est essentiel, tout comme la création de liens avec le secteur privé et les institutions financières pour faciliter l'accès au crédit. Des kits de dignité (serviettes hygiéniques, etc.) doivent être fournis pour réduire les contraintes financières des jeunes filles. Enfin, un accompagnement pour les Health Entrepreneurs est nécessaire pour préserver leurs capitaux et assurer la continuité de leurs activités. Cette approche est cruciale, car l'évaluation révèle que l'autonomie économique est un prérequis à l'autonomie décisionnelle en matière de DSSR, et les bénéficiaires expriment un besoin récurrent de soutien économique.

2. LEÇONS APPRISES ET PISTES POUR LA SUITE

1. Innovations et bonnes pratiques

A. Approche combinée formation technique et transformation des normes (Trajectoire 1.1)

L'approche combinée de formation technique sur le DSSR, la VBG et la PSHEA, associée à la sensibilisation communautaire (SASA/EYAP), a prouvé son efficacité en renforçant les RECOs dans le partage d'informations fiables. Elle leur permet de maîtriser les sujets, de déconstruire des croyances négatives, d'identifier et corriger des messages erronés, tout en impliquant les leaders religieux et les autorités sanitaires pour créer un environnement favorable. Les résultats incluent une augmentation de la fréquentation des structures de santé par les personnes orientées par les RECOs, des orientations vers des avortements sécurisés, une transformation des perceptions communautaires, et une répétition correcte des messages par la communauté. Pour répliquer cette approche, il serait pertinent de l'appliquer à d'autres groupes cibles comme les prestataires de santé et les YATs, de renforcer les formations sur la VBG et la PSHEA, et de multiplier les cadres de changement, notamment à travers des dialogues intergénérationnels.

B. Plaidoyer dirigé par les jeunes (YATs) avec appui technique (Trajectoire 2.1)

Les YATs en groupes structurés de six par zone de santé, soutenue par l'équipe plaidoyer du projet TUMA+, a conduit à des résultats concrets pour responsabiliser les autorités. Les facteurs clés de succès incluent une organisation structurée facilitant la coordination, un appui technique continu de l'équipe plaidoyer TUMA+. Une collaboration entre YATs, l'équipe plaidoyer, les prestataires de santé et les détenteurs de pouvoir, ainsi que la mobilisation de leaders d'opinion en tant qu'alliés. Les résultats observés comprennent l'insertion d'une ligne budgétaire au niveau provincial, l'allocation de budgets mensuels pour l'achat de contraceptifs par certaines ETD, la gratuité des services DSSR pour les jeunes dans plusieurs zones, et la mobilisation de leaders d'opinion. Pour

répliquer cette approche, il est essentiel de renforcer les capacités des YATs en suivi budgétaire et plaidoyer avancé, de créer des réseaux d'échange entre YATs de différentes zones, et d'institutionnaliser les mécanismes de plaidoyer pour garantir la continuité.

D. Intégration des activités dans les structures existantes

L'intégration des activités dans les structures existantes, telles que les centres de santé favorise la pérennité et la durabilité des interventions. Les éléments clés de succès incluent l'intégration institutionnelle des activités dans la routine des centres de santé, la simplicité opérationnelle des activités, leur utilité perçue, et la disponibilité permanente des RECOs dans les communautés. Les résultats observés montrent que les sensibilisations communautaires par les RECOs sont considérées comme les plus durables, que les services intégrés dans les centres de santé continueront après le projet, et que les activités nécessitant peu de ressources externes sont plus pérennes. Il est donc important d'identifier et de renforcer les activités avec le plus fort potentiel de pérennité, d'intégrer progressivement les activités du projet dans les structures officielles, et de renforcer les capacités des acteurs locaux, comme les RECOs et les YATs, pour assurer la continuité.

E. Approche participative et transformation des normes

L'implication active des bénéficiaires, qu'ils soient jeunes, femmes ou hommes, dans les activités et la création d'espaces de dialogue favorisent la transformation des normes sociales et l'appropriation des interventions. Les éléments clés de succès comprennent la participation active des bénéficiaires en tant que facilitateurs et agents de changement, la création d'environnements propices pour discuter de sujets sensibles, la transformation progressive des perceptions communautaires, et l'effet multiplicateur où les participants formés deviennent des agents de changement dans leur communauté. Les résultats observés incluent une augmentation de la confiance des jeunes et des femmes pour poser des questions, des discussions sur le planning familial, des changements notables dans les attitudes des hommes, femmes, jeunes et filles, ainsi qu'un dépassement progressif des mythes autour du DSSR. Pour répliquer cette approche, il est conseillé de multiplier les cadres de changement comme les dialogues intergénérationnels, de renforcer la collaboration avec les leaders religieux et communautaires, et de développer des stratégies spécifiques pour impliquer les parents dans la sensibilisation des jeunes adolescents.

2. Adaptations possibles pour la deuxième moitié du projet

A. Différenciation des stratégies selon les contextes

Développer des stratégies différenciées pour les zones stables vs instables, avec des approches adaptées aux contextes sécuritaires et de contrôle des autorités.

Pour les zones stables (Katwa, Butembo, etc.) :

- Intensifier le plaidoyer institutionnel et les mécanismes de redevabilité
- Institutionnaliser les engagements dans les budgets ETD
- Renforcer le suivi budgétaire DSSR
- Organiser des audiences publiques régulières

Pour les zones instables (Karisimbi, Alimbongo, Bagira, Ibanda) :

- Privilégier les sensibilisations communautaires et la disponibilité des intrants
- Renforcer les infrastructures sanitaires et les capacités des prestataires

- Utiliser des mécanismes de plaidoyer alternatifs (via leaders communautaires, réseaux informels)
- Mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour adapter rapidement les stratégies

L'évaluation révèle que l'impact du plaidoyer est considérablement limité dans les zones où les autorités officielles ne contrôlent plus. Une adaptation contextuelle est essentielle.

B. Renforcement ciblé des thématiques limitées

Intensifier les formations et le renforcement des capacités sur les thématiques où des lacunes ont été identifiées (VBG, PSHEA, hygiène menstruelle).

Actions spécifiques :

- Organiser des formations approfondies et spécifiques sur la VBG et la PSHEA pour les RECOs
- Mettre en place des sessions de renforcement post-formation avec mises en situation pratiques
- Créer un système d'appui technique continu avec référents VBG et PSHEA
- Intégrer spécifiquement la gestion de l'hygiène menstruelle dans les formations
- Développer des modules de sensibilisation adaptés aux collégiens
- Organiser des sensibilisations ciblées dans les écoles

L'évaluation révèle que les RECOs ne possèdent que des "notions" sur la VBG et la PSHEA, insuffisantes pour mener des sensibilisations approfondies. Les bénéficiaires expriment également ces besoins.

C. Intensification des mécanismes de redevabilité

Mettre en place des mécanismes concrets et opérationnels de responsabilisation des détenteurs de pouvoir pour garantir des engagements financiers durables.

Actions spécifiques :

- Créer des comités de suivi budgétaire DSSR au niveau de chaque ETD
- Organiser des réunions trimestrielles obligatoires de redevabilité avec présentation publique
- Formaliser les engagements par des lettres d'engagement signées
- Intégrer une ligne budgétaire DSSR dans les budgets annuels des ETD
- Mettre en place des tableaux de bord de suivi budgétaire affichés publiquement
- Organiser des audiences publiques trimestrielles où les communautés peuvent interpeller les autorités

L'évaluation révèle que les budgets alloués ne sont pas toujours décaissés à temps et que les ruptures d'approvisionnement persistent. Des mécanismes de responsabilisation renforcés sont nécessaires.

D. Renforcement du suivi et de l'apprentissage adaptatif

Mettre en place un système de suivi continu permettant des ajustements rapides et un apprentissage adaptatif.

Actions spécifiques :

- Mettre en place des mécanismes de feedback réguliers (mensuels) avec les bénéficiaires, RECOs, YATs et prestataires
- Créer des espaces de dialogue trimestriels pour identifier rapidement les défis et ajuster les stratégies

- Développer des indicateurs simples et pertinents permettant de mesurer l'évolution des changements comportementaux et normatifs
- Documenter systématiquement les leçons apprises et les partager entre zones
- Organiser des ateliers d'apprentissage semestriels pour capitaliser sur les expériences
- Mettre en place des systèmes de suivi post-activités pour accompagner les bénéficiaires

L'évaluation révèle des besoins de suivi post-activités et des défis qui nécessitent des ajustements rapides. Un système d'apprentissage adaptatif permettra d'améliorer l'efficacité.

E. Démarrage anticipé de la transition et pérennisation

Commencer dès maintenant à intégrer des mécanismes de pérennisation dans toutes les activités et à préparer la transition post-projet.

Actions spécifiques :

- Identifier et documenter les activités ayant le plus fort potentiel de pérennité
- Renforcer les capacités des RECOs et YATs pour qu'ils puissent continuer leurs activités de manière autonome
- Intégrer progressivement les activités du projet dans les structures officielles (centres de santé, ETD)
- Développer des stratégies de financement local pour les activités essentielles
- Créer des réseaux d'appui mutuel entre zones pour partager les ressources et expériences
- Élaborer des plans de transition documentés pour chaque activité clé

Les participants expriment des préoccupations sur la continuité après le projet. Il est crucial de commencer la transition dès maintenant pour garantir la durabilité.

F. Renforcement économique pour l'autonomie décisionnelle

Intensifier les interventions économiques (AGR, épargne) pour renforcer l'autonomie économique des femmes et jeunes, prérequis à l'autonomie décisionnelle en matière de DSSR.

Actions spécifiques :

- Renforcer les AVEC existantes et créer de nouvelles AVEC dans les zones ciblées
- Développer des AGR individuelles en plus des AGR collectives
- Diversifier les activités génératrices de revenus selon les contextes locaux
- Renforcer les capacités d'épargne et de gestion financière des bénéficiaires
- Créer des liens avec le secteur privé et les institutions financières
- Fournir des kits de dignité pour réduire les contraintes financières des jeunes filles
- Accompagner les Health Entrepreneurs pour préserver leurs capitaux

L'évaluation révèle que l'autonomie économique est un prérequis à l'autonomie décisionnelle en matière de DSSR. Les bénéficiaires expriment un besoin récurrent de soutien économique.

G. Amélioration de la qualité des services et de l'accueil

Intensifier les formations et le renforcement des capacités des prestataires de santé pour améliorer la qualité de l'accueil et des services.

Actions spécifiques :

- Organiser des formations spécifiques sur l'accueil des jeunes et femmes sans jugement, avec focus sur la confidentialité et le respect

- Mettre en place des mécanismes de feedback des bénéficiaires (boîtes à suggestions, enquêtes de satisfaction)
- Créer des systèmes de suivi pour vérifier que les services restent gratuits pour les jeunes
- Organiser des visites de supervision pour observer les pratiques d'accueil
- Développer des protocoles d'accueil standardisés pour les jeunes et femmes
- Former sur l'importance de ne pas facturer les services DSSR aux jeunes

Les bénéficiaires expriment un besoin récurrent d'amélioration de l'accueil et de la confidentialité.

La qualité des services est un facteur clé d'utilisation.